

Économie de la santé : théories de la régulation, financement du risque et politiques publiques de protection sociale

Introduction générale

L'économie de la santé s'est imposée comme une branche maîtresse et autonome de la science économique au début des années 1960, portée par la prise de conscience des spécificités irréductibles du bien santé et des défaillances systémiques de son marché. Longtemps appréhendée sous un angle strictement médical ou caritatif, la santé est aujourd'hui reconnue comme un secteur macroéconomique de premier ordre, un capital productif majeur pour les nations et un droit humain fondamental. Historiquement, le jalon doctrinal fondateur a été posé par Kenneth Arrow en 1963 dans son article pionnier sur l'incertitude et l'économie du bien-être dans les soins médicaux, qui a démontré scientifiquement pourquoi le marché de la santé ne peut s'autoréguler par les mécanismes de la concurrence pure et parfaite. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Sur le plan des politiques publiques et de l'économie politique, la gestion de la santé oppose et articule la recherche de la performance médicale avec l'impératif de la soutenabilité budgétaire. Les crises sanitaires mondiales contemporaines ont rappelé que la sécurité sanitaire internationale est un bien public mondial, directement connecté à la stabilité des marchés financiers, aux chaînes de valeur globales et à la souveraineté des États. L'intérêt de ce sujet pour les concours de la haute fonction publique de cycle A est immense : la gestion des hôpitaux publics, le financement de l'assurance maladie, la régulation des industries pharmaceutiques et la lutte contre les inégalités territoriales de santé constituent des défis régaliens majeurs. Pour les pays en développement, et singulièrement pour le Sénégal au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, l'économie de la santé est au cœur des stratégies d'urgence. La problématique centrale de ce cours repose sur la capacité des politiques publiques à concevoir des systèmes de financement de la santé qui garantissent une couverture sanitaire universelle efficace sans compromettre l'équilibre macroéconomique et budgétaire des finances publiques nationales.

I. Les fondements théoriques, doctrinaux et conceptuels de l'économie de la santé

L'intégration de la santé dans l'analyse économique exige de déconstruire les modèles standards pour appréhender les concepts d'incertitude, d'asymétrie d'information et de capital humain.

A. Les défaillances de marché caractérisées : incertitude, antisélection et aléa moral

Le fondement de l'économie de l'ensemble des systèmes de santé repose sur la théorie de l'incertitude et des asymétries d'information, théorisée à l'origine par Kenneth Arrow.

Contrairement aux biens marchands ordinaires, le consommateur de soins (le patient) est confronté à une incertitude double : il ignore quand il tombera malade et il ne connaît pas la nature ni l'intensité des soins dont il aura besoin pour guérir. Pour se prémunir contre ce risque financier, les individus se tournent vers des mécanismes d'assurance. C'est à ce niveau qu'apparaissent les défaillances de marché de l'antisélection (ou sélection adverse) et de l'aléa moral. L'antisélection survient lorsque l'assureur privé ne peut distinguer les profils à risque des assurés. Si l'assureur fixe une prime moyenne, les individus en bonne santé quittent le marché, estimant la prime trop élevée, tandis que les individus malades y restent. Ce mécanisme cumulatif

conduit à une hausse continue des primes et à l'effondrement du marché de l'assurance privée, légitimant l'intervention de l'État par le biais d'une assurance maladie obligatoire ou d'un financement par l'impôt pour mutualiser les risques à l'échelle nationale. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

L'aléa moral, quant à lui, désigne la modification du comportement de l'assuré ou du prestataire de soins du fait même de l'existence de la couverture du risque. On distingue l'aléa moral ex ante, où l'assuré réduit ses efforts de prévention en sachant ses frais médicaux couverts, et l'aléa moral ex post, caractérisé par une surconsommation de soins médicaux gratuits ou fortement subventionnés. De surcroît, le marché de la santé est marqué par une asymétrie d'information radicale entre le patient et le médecin. Le médecin dispose du monopole du savoir technique, ce qui lui permet de définir à la fois l'offre et la demande de soins. Cette situation engendre le mécanisme microéconomique de la demande induite par l'offre, où le professionnel de santé peut être incité à prescrire des actes médicaux ou des médicaments superflus pour maximiser ses propres revenus, si le mode de rémunération n'est pas rigoureusement régulé par la puissance publique. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

B. La théorie du capital humain et la santé comme bien de consommation et d'investissement [\[1\]](#)

Pour comprendre l'impact macroéconomique de la santé sur le développement, les économistes mobilisent la théorie du capital humain, initiée par Gary Becker et adaptée spécifiquement à la santé par Michael Grossman en 1972. Le modèle de Grossman postule que la santé n'est pas seulement un bien de consommation qui procure une utilité immédiate (le bien-être de ne pas souffrir), mais un bien d'investissement à long terme. Chaque individu naît avec un stock initial de santé qui se déprécie avec le temps et l'âge, mais qui peut être accru par des investissements judicieux en soins médicaux, en nutrition équilibrée, en hygiène de vie et en prévention. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

L'apport macroéconomique de ce modèle est crucial pour les politiques de développement : un stock de santé élevé augmente le nombre de jours disponibles pour le travail productif et élève la productivité marginale du travailleur. Des populations en bonne santé apprennent mieux à l'école, innovent davantage et travaillent plus longtemps, générant des externalités positives massives sur la croissance économique globale et le PIB d'une nation. À l'inverse, la maladie et la malnutrition agissent comme des taxes structurelles sur le développement, provoquant de l'absentéisme, une perte de capital humain irréversible chez les enfants et une allocation inefficace de l'épargne des ménages vers des dépenses de survie médicale de court terme, maintenant les économies fragiles dans des trappes à pauvreté structurelles. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

II. Les modèles de financement des systèmes de santé et la gouvernance internationale

La structuration des systèmes de santé oppose plusieurs modèles de protection sociale dont la mise en œuvre s'articule avec les orientations des grandes organisations internationales.

A. La confrontation des modèles nationaux : Beveridge, Bismarck et le modèle libéral market-driven

La littérature en économie politique compare les systèmes de santé mondiaux à travers trois grands modèles types de financement et d'organisation. Le premier est le modèle bismarckien, d'inspiration allemande, fondé sur l'assurance sociale obligatoire liée au travail. Ce système est financé principalement par des cotisations sociales prélevées sur les salaires, cogéré par les partenaires sociaux et offre des prestations de soins proportionnelles aux cotisations, protégeant en priorité les travailleurs et leurs ayants droit, bien qu'il ait évolué vers une universalisation progressive des droits. Le second est le modèle beveridgien, d'inspiration britannique, caractérisé

par le National Health Service. Ce modèle repose sur le triptyque de l'universalité (couverture de l'ensemble de la population), de l'uniformité des prestations et de la gratuité des soins au point de service. Il est financé de manière prépondérante par l'impôt et géré directement par l'État central, érigeant la santé en un service public républicain universel. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

À l'opposé de ces modèles de solidarité publique se trouve le modèle libéral, ou *market-driven*, incarné historiquement par les États-Unis. Dans ce système, la santé est appréhendée comme un bien marchand privé régulé par les mécanismes du marché et de l'assurance privée commerciale, le rôle de l'État se cantonnant à des programmes ciblés de subsidiarité sociale pour les personnes âgées (Medicare) ou les plus démunis (Medicaid). L'analyse économique montre que ce modèle libéral génère de graves inefficacités allocatives, caractérisées par des coûts de gestion administratifs exorbitants, une inflation des prix des soins médicaux et une exclusion d'une part importante de la population de l'accès aux soins de base. C'est pourquoi la tendance macroéconomique mondiale, soutenue par les évaluations de performance publique, s'oriente vers des modèles hybrides intégrant une régulation étatique forte pour encadrer les prix, contrôler l'offre de soins et garantir l'équité d'accès via des paniers de soins de base universels. [[1](#)]

B. L'action de l'OMS, de la Banque mondiale et le concept de couverture sanitaire universelle

La gouvernance internationale de l'économie de la santé est pilotée par l'Organisation mondiale de la santé, qui promeut le concept de Couverture sanitaire universelle (CSU) au titre des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. La CSU implique que tous les individus aient accès aux services de santé de qualité dont ils ont besoin sans que cela ne les expose à des difficultés financières insurmontables ou à la faillite économique en raison des paiements directs de leur poche (*Out-of-pocket payments*). L'OMS fixe des cadres méthodologiques pour aider les pays à concevoir des architectures de préfinancement solidaires (impôt ou assurance maladie obligatoire) permettant de réduire la part du paiement direct, identifié comme le principal vecteur d'appauvrissement des populations dans les pays du Sud. [[1](#), [2](#)]

Parallèlement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont profondément modifié leur doctrine en matière de santé publique. Après avoir imposé, durant l'ère de l'ajustement structurel, des politiques de recouvrement des coûts et l'introduction de tickets modérateurs dans les hôpitaux publics — qui ont drastiquement réduit l'accès des plus pauvres aux soins de base —, ces institutions financières reconnaissent désormais que la santé est un investissement productif indispensable. La Banque mondiale est devenue l'un des principaux bailleurs multilatéraux pour le financement des réformes de la protection sociale et du renforcement des systèmes de santé nationaux, liant l'octroi de ses financements à la mise en œuvre de mécanismes de ciblage équitable et d'évaluation de la performance managériale des services de santé. [[1](#), [2](#)]

III. Économie de la santé en Afrique de l'Ouest : transition épidémiologique, assurance maladie et modèle du Sénégal

L'application de l'économie de la santé en Afrique subsaharienne doit relever le défi d'une double charge de morbidité au sein d'espaces régionaux en quête d'harmonisation de leur protection sociale.

A. Le défi de la transition épidémiologique et les politiques d'harmonisation de l'UEMOA et de la CEDEAO

Les systèmes de santé d'Afrique de l'Ouest sont confrontés à un phénomène complexe de transition épidémiologique inachevée. Ils doivent simultanément faire face au fardeau persistant

des maladies infectieuses et parasitaires traditionnelles (paludisme, tuberculose, VIH, épidémies saisonnières) et à l'émergence fulgurante des maladies chroniques non transmissibles liées aux mutations des modes de vie urbains (diabète, maladies cardiovasculaires, cancers). Cette double charge sanitaire exerce une pression colossale sur des infrastructures médicales fragiles et exige une allocation optimale de ressources financières publiques structurellement limitées, d'autant plus que les critères de convergence de l'UEMOA encadrent strictement les marges de manœuvre budgétaires des États membres. [\[1\]](#)

Pour rationaliser l'action publique, l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), agence spécialisée de la CEDEAO, met en œuvre des politiques de mutualisation à l'échelle régionale. L'OOAS orchestre l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques pour faciliter l'achat groupé de médicaments essentiels génériques, l'homologation des produits médicaux et le développement d'une industrie pharmaceutique locale capable de réduire la dépendance de l'Afrique de l'Ouest vis-à-vis des importations mondiales, qui représentent plus de quatre-vingts pour cent des besoins de consommation. Au sein de l'UEMOA, des réflexions communautaires sont menées pour harmoniser les cadres juridiques de la mutualité sociale, afin de faciliter la transférabilité des droits à la protection sociale des travailleurs migrants et de bâtir un espace de sécurité sanitaire partagé.

B. Le Plan Sénégal Émergent et la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle

Le Sénégal a placé la santé au cœur de sa stratégie de développement humain au sein de l'Axe Deux du Plan Sénégal Émergent, ayant compris que l'émergence économique est indissociable de la solidité du capital humain. Le pays s'est engagé dans une réforme historique à travers le déploiement du programme national de Couverture maladie universelle (CMU), destiné à étendre la protection contre le risque maladie à l'ensemble de la population, et particulièrement au secteur informel de l'économie populaire et au monde rural, historiquement exclus des régimes de sécurité sociale classiques réservés aux fonctionnaires et aux salariés du secteur formel (IPM). [\[1\]](#)

La stratégie de la CMU au Sénégal repose sur un modèle d'économie sociale et solidaire innovant : l'extension du réseau des mutuelles de santé communautaires à l'échelle des communes du territoire national. L'État subventionne à hauteur de cinquante pour cent les cotisations des adhérents de ces mutuelles et prend en charge l'intégralité de la cotisation pour les ménages les plus pauvres inscrits dans le Registre national unique (RNU) via les bourses de sécurité familiale. Parallèlement, les politiques publiques ont déployé des mesures d'exemption de paiement des soins pour des publics vulnérables ciblés, à l'instar de la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans, de la gratuité des accouchements et des césariennes, et du plan Sésame pour les personnes âgées. Le grand défi futur de la fonction publique de la santé au Sénégal consistera à pérenniser les mécanismes de financement de ces politiques de gratuité par des ressources fiscales endogènes stables, à améliorer l'offre de soins et les plateaux techniques des hôpitaux publics régionaux pour répondre à la demande sociale croissante, et à introduire des méthodes de régulation et d'évaluation managériale rigoureuses pour lutter contre les risques de dérive financière et d'inefficiences allocatives. [\[1, 2\]](#)

Conclusion générale

L'économie de la santé démontre que la santé publique n'est pas un simple poste de dépenses budgétaires passives ou d'assistance sociale, mais un pilier structurel de l'économie politique contemporaine et un investissement productif indispensable à la formation du capital humain d'une nation. Les défaillances de marché caractérisées, liées à l'incertitude et aux asymétries d'information, prouvent le caractère illusoire et inefficace d'une régulation par les seuls

mécanismes marchands concurrentiels, érigeant la puissance publique en architecte obligatoire de la mutualisation des risques et de la justice sociale. La gouvernance internationale de la santé, guidée par les objectifs de la couverture sanitaire universelle, consacre la nécessité d'articuler la solidarité financière avec la rigueur managériale. [\[1\]](#)

Pour un candidat aux concours administratifs supérieurs de cycle A, la maîtrise rigoureuse de ces concepts économiques et institutionnels est indispensable pour appréhender la complexité de l'action publique moderne. Il convient de retenir que pour un État comme le Sénégal, la réussite des politiques de santé, à l'instar de la Couverture maladie universelle, repose sur sa capacité à concilier l'inclusion sociale de l'économie populaire rurale et urbaine avec les exigences de soutenabilité budgétaire nationale et régionale encadrées par l'UEMOA. Le futur administrateur de la haute fonction publique devra être apte à piloter des systèmes de préfinancement solidaire innovants, à optimiser la gestion des hôpitaux publics par des techniques de contractualisation, et à concevoir des politiques de prévention efficaces, transformant ainsi la sécurité sanitaire en un levier souverain de développement humain et d'émergence durable pour l'ensemble du continent africain.